EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 85389
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 2024-05-28 08:14:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JULIA DEL CARMEN LABRIN RODRIGUEZ			RUN	: 6.895.069-4
F.Nac	: 20-10-1928	Edad	: 95 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: NINQUIHUE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 99369243		
Fecha Ingreso	: 2024-05-26	Fecha Egreso	: 2024-05-28 08:14:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J10.1-INFLUENZA CON OTRAS MANIFE. RESP., DEBIDAS A VIRUS DE LA IN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-Neumonia por Influenza A
2-Falla Renal Aguda En Resuelta
3- ITU

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J12.9-NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 95 años semindependiente con antecedente mórbidos de HTA, Tratamiento farmacológico habitual telmisartan 80 mg 1 - ½ carvedilol 25 mg 1-1 amlodipino 5 mg 1/2-0 bonavid 300.000 ui 5 gotas semana por medio, sin alergias conocidas, antecedentes quirúrgico colecistectomía, cx de fx ESD. niega habito tabáquico y oh.
Es Traída por familiar al servicio de Urgencia, quien refiere hace 4 dias tos, congestión nasal, calofríos, desde ayer CEG, disnea, sibilancias audibles a distancia, fiebre, cuadro de desorientación, relajación de esfínter vesical. A su ingreso paciente en REG, al csv de ingreso taquipneica, sat 85 % fio2 al 21%. Glasgow 15 pts, piel palida, tibia al tacto, llene capilar <3 seg, pirrl, yugulares planas, torax simetrico con uso de musculatura accesoria, tos productiva, sibilancia, disnea al esfuerzo, abdi a la palpación, moviliza ext, edema (-).
Realizo ev kinésica + ktr ttkk DB/AFE/tos dirigida, expectora SB purulentas fluidas + ultima NBZ con berodual 3:1, post knt aumenta la sato2 95%, informo, mantengo 4 l/m, finalizo sin incidentes, se ingresa ala servicio de medicina con mejoría de la clínica, con parámetros inflamatorios a la baja, titulando oxígeno, tolerando alimentación vo.
Se recata urocultivo polimicrobiano.
TAC de Tórax: Signos de Neumopatía Basal Derecha de Probable Etiología Inflamatoria Infecciosa. Cardiomegalia global. Leve Ateromatosis Cálcica Aortica. Bocio Multinodular.
Exámenes control: Proteina C Reactiva: 70,8 * mg/L leucocitos : 9,40 mil/ul Recuento Hematies : 4,15 Mill/ul Hematocrito : 38,9 o/o Hemoglobina : 13,4 g/dl V Plaquetas : 184 Segmentados : 86 * o/o Linfocitos : 8 * o/o Monocitos : 3 V.H.S. : 40 Procalcitonina : 0,72 ng/mL pH : 7,38 pCO2 : 32,3 * mmHg pO2 : 76,1 * mmHg
Sin requerimiento de oxigeno por mas de 24 horas a febril, en condiciones de seguir tto con hospitalización domiciliaria.

PLAN DE MANEJO:

Mantener tto ATB De Primera Linea
Mantiene Terapia Broncodilatadora + Knt Respiratoria por Hodom
Pendiente rescatar Cultivo Expectoración

INDICACIONES AL ALTA

1. Hodom
2. hidratación oral con 1000 cc diarios
3. Paracetamol 1g E cada 8 horas vo Sos
4. Ceftriaxona 2g Dia por 5 dias ev
5. Oseltamivir 75 Mg Via Oral Cada 12 Horas
6. Azitromicina 500mg dia por 3 dias
7. Bromuro Ipatropio 4 Puff C/6h
8. Salmeterol Fluticasona 2 Puff C/12h
9. Knt Respiratoria por 2 veces
10. Examensn control en 48 horas
11. Continuar con tto crónico

EXÁMENES Y RESULTADOS

Creatinina : 1,10 * mg/dl 0,52 - 1,04
Clearence Calculado(MDRD) : 46,15
Lactato : 0,9
Sodio (Na) : 138,00 mmol/L
Potasio (K) : 4,40 mmol/L
Cloro (Cl) : 104,00
leucocitos : 6,00 mil/ul 3,80 - 11,80
Recuento Hematies : 3,93 * Mill/ul 4,00 - 5,20
Hematocrito : 36,4 o/o 31,2 - 41,9
Hemoglobina : 12,7

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO